

Akut Karın Ağrısı

Cerrahi karnı (apandisit, invajinasyon, midgut volvulus, over torsiyonu) hızlı tanımaya, alarm bulgularını ayırt etmeye, doğru görüntülemeyi seçmeye ve zamanında cerrahi konsültasyon vermeye yönelik karar aracı. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Cerrahi karın

Alarm bulguları

Görüntüleme

Cerrahi konsültasyon

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Akut karın ağrısı, genellikle 7 günden kısa süren, yeni başlangıçlı karın ağrısıdır; kritik görev, acil cerrahi girişim gerektiren "cerrahi karnı" (apandisit, invajinasyon, malrotasyon-volvulus, over/testis torsiyonu, inkarsere herni, perforasyon) medikal taklitçilerden ayırmaktır. Yaş, ağrının paterni (ani-şiddetli vs. sinsi), lokalizasyon ve eşlik eden safralı kusma tanısız olasılığı belirler: infantta safralı kusma aksi kanıtlanana dek midgut volvulusudur; 3 ay-3 yaş arası paroksizmal ağrı + kanlı-mukuslu gaita invajinasyonu, okul çağı-adölesanda göç eden sağ alt kadranda ağrısı apandisiti, adölesan kızda ani unilateral pelvik ağrı over torsiyonunu düşündürür. Analjezi cerrahi karnı maskeleyemez; erken uygun analjezi verilmelidir.

Cerrahi karnı erken tanı

Safralı kusma = volvulus kanıtlanana dek

Yaşa özgü ayırıcı tanı

Analjezi tanıyı geciktirmez

Öyküde sorgula

- Ağrı: başlangıç şekli (ani/kolik vs. sinsi), süre, göç (periumbilikal → sağ alt kadranda = apandisit), şiddet, hareketle-öksürükle artış (periton irritasyonu)
- Kusma: safralı mı (obstrüksiyon/volvulus), fekaloid mi; kusma ağrıdan önce mi sonra mı (kusma sonra başlarsa cerrahi lehine)
- Gaita: kanlı-mukuslu ("çilek jölesi" — invajinasyon), ishal, akolik, gaz-gaita kesilmesi (obstrüksiyon)
- İdrar: dizüri, hematüri, sıklık (üriner sistem); adölesan kızda son adet tarihi, cinsel aktivite, gebelik olasılığı
- Sistemik: ateş, iştahsızlık, letarji, epizodik solukluk-çekilme atakları (invajinasyon)
- Ek: travma, geçirilmiş batin cerrahisi (adezyon), bilinen orak hücre/İBH, ilaç, aşılama; ekstraabdominal (boğaz, akciğer, testis) öykü

Muayenede değerlendir

- Genel/vital: hemodinami (taşikardi, hipotansiyon, kapiller dolum), ateş, dehidratasyon, toksik görünüm, ağrıyla kıvrınma (kolik) vs. kıpırdayamama (peritonit)
- Batın: distansiyon, defans-rebound-rigidite (peritonit), lokalize hassasiyet (McBurney), palpabl kitle (sağ üst kadranda sosis kitle = invajinasyon), barsak sesleri
- Özel bulgular: psoas/obturator/Rovsing (apandisit), sıçratma/topuk vurma ağrısı
- Kasık ve genital: mutlaka muayene — inkarsere/strangüle herni, testis torsiyonu (akut skrotum), adneksiyal hassasiyet-kitle

- Rektal (endikasyonla): kanama, kitle, hassasiyet
- Ekstraabdominal: farenjit, alt lob pnömonisi, purpura (IgA vaskülit/HSP), ketotik nefes (DKA)

Kırmızı çizgi: Peritonit bulgusu (yaygın defans-rebound, tahta karın), safralı kusma, hemodinamik bozukluk veya akut skrotum/adneksiyal torsiyon şüphesi varsa değerlendirme ve resüsitasyon ile **eşzamanlı acil cerrahi/üroloji-jinekoloji konsültasyonu** istenir; tetkik tamamlanması cerrahi çağrısını geciktirmemelidir.

Akut karın ağrısının cerrahi nedenleri mekanizma ve yaşa göre ayrışır; her kategorinin karakteristik prezentasyonu ilk-basamak görüntülemeyi ve konsültasyon aciliyetini belirler.

Akut apandisit

- En sık cerrahi neden; pik okul çağı-adölesan, <5 yaşta atipik ve sık perforedir
- Periumbilikal → sağ alt kadrana göçen ağrı, anoreksi, ateş, kusma
- İlk görüntüleme USG (>6 mm, komprese olmayan, apandikolit); şüpheli ise MR/BT

İnvajinasyon

- 3 ay-3 yaş (pik 5-9 ay); çoğu ileokolik ve idiyopatik (lenfoid hiperplazi)
- Paroksizmal ağrı-çekilme atakları, "çilek jölesi" gaita, sosis kitle, letarji
- USG "hedef/donut" işareti tanısallı; tedavi hava/kontrast enema redüksiyonu

Malrotasyon + midgut volvulus

- En sık ilk ayda; her yaşta olabilir. Gerçek cerrahi acil
- Safralı kusma ± ani şiddetli ağrı; erken batin normal olabilir (aldatıcı)
- Üst GİS pasaj altın standart; USG'de "whirlpool"/SMA-SMV ters dönmesi; acil Ladd

Over / adneksiyal torsiyon

- Adölesan kız (kist/kitle zemininde; menarş öncesi de olabilir)
- Ani, şiddetli, unilateral pelvik ağrı; bulantı-kusma, adneksiyal hassasiyet-kitle
- Renkli Doppler USG; akım korunabilir — normal Doppler torsiyonu DIŞLAMAZ; acil detorsiyon

Diğer cerrahi aciller

- İnkarere/strangüle inguinal herni; testis torsiyonu (akut skrotum — batin ağrısıyla gelebilir)
- Meckel divertikülü (ağrısız kanama ya da divertikülit/obstrüksiyon), obstrüksiyon (adezyon)
- İçi boş organ perforasyonu → serbest hava, peritonit, septik şok

Cerrahi dışı (medikal) taklitçiler

- Gastroenterit, mezenterik lenfadenit, kabızlık, üriner enfeksiyon/taş
- Ekstraabdominal: alt lob pnömonisi, streptokoksik farenjit, IgA vaskülit (HSP)
- Metabolik/sistemik: diyabetik ketoasidoz, orak hücre krizi, FMF, HÜS

Yaş kuralı: İnfantta safralı kusma → malrotasyon-volvulus; süt çocuğunda paroksizmal ağrı + kanlı gaita → invajinasyon; okul çağı-adölesanda göçen sağ alt kadrana ağrısı → apandisit; adölesan kızda ani pelvik ağrı → over torsiyonu / ektopik gebelik (gebelik testi zorunlu).

03 Karar akışı

İlk çatal hayatı tehdit eden cerrahi karın / şoktur; ikinci çatal, stabil çocukta hedefli görüntüleme ve klinik skorun cerrahi patolojiyi gösterip göstermediğidir.

BAŞLANGIÇ

Akut karın ağrısı (<7 gün)

Yeni başlangıçlı, giderek artan veya paroksizmal ağrı; hedef cerrahi karını medikal nedenden ayırmak.

ADIM 1

Stabilizasyon + odaklı öykü/muayene

ABC ve vital, ağrı paterni, safralı kusma sorgusu, kasık-genital-skrotum muayenesi; adölesan kızda gebelik testi, glukoz/ketoasidoz taraması; erken analjezi.

KARAR 1

Cerrahi acil / peritonit / şok bulgusu var mı?

Yaygın defans-rebound-rigidite, safralı kusma, distansiyonla obstrüksiyon, hemodinamik bozukluk, akut skrotum veya adneksiyal torsiyon şüphesi.

EVET → Acil müdahale

HAYIR → Stabil değerlendirme

ACİL

Resüsitasyon + hemen cerrahi/ üroloji-jinekoloji konsültasyonu

NPO, geniş damar yolu, 20 mL/kg izotonik bolus, analjezi-antiemetik, gerekirse antibiyotik; görüntüleme resüsitasyonla eşzamanlı, konsültasyonu geciktirmeden.

KATMANLA

Yaşa göre risk + hedefli görüntüleme

Lab (tam kan, CRP, TİT, $\pm$ amilaz/lipaz), klinik skor (apandisit PAS/Alvarado); ilk basamak USG. Tanı belirsizse gözlemde seri muayene.

KARAR 2

Görüntüleme/klinik cerrahi patoloji gösteriyor mu?

USG'de apandisit, invajinasyon "hedef" işareti, adneksiyal torsiyon, whirlpool; ya da yüksek klinik skor / ilerleyen bulgular.

EVET → Tanıya yönelik

HAYIR → Medikal neden / gözlem

GİRİŞİM

YÖNET

Cerrahi konsültasyon ve tedavi

Apandisit → cerrahi/antibiyotik; invajinasyon
→ hava-kontrast enema redüksiyonu
(kontrendikasyon yoksa); volvulus → acil
Ladd; over/testis torsiyonu → acil detorsiyon.

Nedene yönelik tedavi + güvenlik ağı

Gastroenterit, kabızlık, ÜSYE/pnömoni, İYE
gibi nedenleri tedavi et; belirsizse aktif
gözlem ve 12-24 saatte tekrar
değerlendirme, kötüleşmede yeniden
görüntüle.

Tetkik klinik olasılığa göre kademeli ilerler; ultrasonografi çocukta ilk basamak modalitedir (radyasyonsuz), ileri görüntüleme (BT) tanı belirsiz veya komplike olgulara ayrılır. Hemodinamik olarak stabil olmayan cerrahi karın, tetkiki beklemeden konsültasyon ve resüsitasyon gerektirir.

Akut karın ağrısında kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Yatak başı	Vital, kapiller glukoz + kan ketonu, adölesan kızda idrar/serum β -hCG, tam idrar tetkiki	Şok/DKA taraması; gebelik-ektopik ekartasyonu (görüntüleme öncesi zorunlu); İYE/taş, hematüri
Basamak 2 · Kan	Tam kan sayımı, CRP, elektrolit-üre-kreatinin, KCFT, amilaz/lipaz, venöz kan gazı + laktat; endikasyonla grup-crossmatch	İnflamasyon (nötrofili+CRP apandisiti destekler ama normal dışlamaz), pankreatit, dehidratasyon-asidoz, sepsis; cerrahi öncesi hazırlık
Basamak 3 · İlk görüntüleme	Abdomen/pelvis ultrasonografisi; şüphede renkli Doppler (over/testis)	İlk basamak modalite — apandiks >6 mm komprese olmaz, invajinasyon "hedef/donut", adneksiyal torsiyon, whirlpool; negatif USG apandisiti dışlamaz
Basamak 4 · Direkt grafi	Ayakta/yan dekübit direkt batın grafisi	Serbest hava (perforasyon), hava-sıvı seviyeleri/obstrüksiyon, fekalit; sınırlı duyarlılık, seçili endikasyon
Basamak 5 · Kontrast çalışma	Üst GİS pasaj grafisi (malrotasyon); hava veya suda çözünür kontrast enema (invajinasyon)	Bilious kusmada üst GİS altın standart; invajinasyonda enema hem tanısal hem tedavi edicidir (peritonit/perforasyon/şokta kontrendike)

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 6 · İleri görüntüleme	BT (İV kontrastlı) veya MR	USG belirsiz/komplike, apse/perforasyon, obez hasta; radyasyondan kaçınmak için mümkünse MR tercih; BT'yi tanıyı değiştirecekse kullan
Seçili · Klinik skor	Pediyatrik Apandisit Skoru (PAS) / Alvarado	Düşük skorda güvenli gözlem, yüksek skorda cerrahi; orta skorda görüntüleme ile stratifikasyon (tek başına tanı koydurmaz)

Not: Görüntülemesi negatif ama klinik şüphesi süren stabil çocukta en güvenli yaklaşım **aktif gözlem ve seri muayenedir**; erken evre apandisit ve invajinasyon başlangıçta USG'de görülmeyebilir, saatler içinde tekrar değerlendirme tanısal değeri artırır.

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdakilerden herhangi biri cerrahi karın veya hayatı tehdit eden neden lehinedir; hızlı görüntüleme ve eşzamanlı cerrahi/üroloji-jinekoloji konsültasyonunu gerektirir.

● Safralı (yeşil) kusma — kanıtlanana dek malrotasyon-volvulus

● Peritonit: yaygın defans, rebound, tahta karın, hareketle-öksürükle artan ağrı

● Hemodinamik bozukluk / toksik görünüm / septik şok

● Distansiyon + gaz-gaita kesilmesi (obstrüksiyon)

● Palpabl abdominal kitle (invajinasyonda sosis kitle)

● Paroksizmal ağrı + "çilek jölesi" / kanlı-mukuslu gaita + letarji

● Akut skrotum (testis torsiyonu) veya ani unilateral pelvik ağrı (over torsiyonu)

● İnkarsere/strangüle kasık-göbek fıtığı (indirgenemeyen, hassas kitle)

● GİS kanama: hematemez, melena, masif rektal kanama

● Adölesan kızda pozitif gebelik testi + pelvik ağrı (ektopik gebelik)

● Şiddetli, ilerleyen, hareketsiz kalmaya zorlayan lokalize ağrı

● Geçirilmiş batin cerrahisi + obstrüksiyon bulgusu (adeziv ileus)

06 Tedavi

İlk yönetim tüm cerrahi karın şüphelerinde ortaktır: NPO, damar yolu, sıvı resüsitasyonu, analjezi-antiemetik ve endikasyonda antibiyotik; tanıya özgü kesin tedavi (enema redüksiyonu, apendektomi/antibiyotik, Ladd, detorsiyon) konsültanla birlikte planlanır. Erken analjezi tanısal değerlendirmeyi bozmaz ve verilmelidir.

İlk stabilizasyon ve semptomatik tedavi		
BASAMAK / İLAÇ	DOZ	NOT
NPO + nazogastrik dekompresyon	—	Obstrüksiyon, kusma/boşaltım şüphesi, aspirasyon, distansiyon
İzotonik sıvı bolusu (SF veya RL)	20 mL/kg IV bolus; yanıtı göre tekrarlar (şokta hızlı)	İdame + idrar çıkışı, perfüzyon, hipoglisemi, protokole düzelt
Morfin (analjezi)	0,05-0,1 mg/kg/doz IV (maks 4-5 mg/doz)	Cerrahi maskeleme et. Alter fentanil (maks 5
Parasetamol (hafif-orta ağrı)	15 mg/kg/doz IV/PO (maks 1 g/doz, 4 g/gün)	Opioid gereksinimi azaltır; cerrahi/riskinde
Ondansetron (antiemetik)	0,15 mg/kg/doz IV (maks 8 mg/doz)	Kusma-dehidratasyon, QT uzatma birlikteli
Taniya özgü tedavi (cerrahi/girişimsel ekiple birlikte)		

TANI	TEDAVİ / DOZ
Komplike apandisit / perforasyon-peritonit	Piperasilin-tazobaktam 100 mg/kg/doz (piperasilin) IV c
Komplike olmayan apandisit	Perioperatif tek doz sefoksitin 40 mg/kg (maks 2 g) ± a
İnvajinasyon	Hava enema redüksiyonu (basınç genelde ≤ 120 mmHg
Malrotasyon + midgut volvulus	Acil Ladd prosedürü (cerrahi); resüsitasyon + geniş sı

TANI	TEDAVİ / DOZ
Over / adneksiyal torsiyon	Acil laparoskopik detorsiyon (over koruyucu); analjezi
Testis torsiyonu / inkarsere herni	Acil cerrahi eksplorasyon-detorsiyon / herni onarımı

Yaklaşım: Cerrahi karın şüphesinde sıra — NPO, resüsitasyon ve analjezi ile **eşzamanlı** konsültasyon; görüntüleme tedaviyi geciktirmemeli. Antibiyotik yalnızca perforasyon/peritonit/sepsis veya planlı apendektomi perioperatifinde başlanır; basit gastroenteritte antibiyotik gereksizdir.

Tanısı netleşmemiş stabil çocukta ampirik antibiyotik ve gereksiz opioid yükünden kaçın; bunun yerine aktif gözlem, seri muayene ve gerektiğinde tekrar görüntüleme ile ilerle.

Akut karın ağrısının önemli kısmı kendini sınırlayan medikal nedenlerdir; ancak erken evre cerrahi patoloji atlanabildiğinden yönetim, seri değerlendirme ve net güvenlik ağı üzerine kuruludur. Hedef: cerrahi karnı zamanında yakalamak, gereksiz radyasyon-cerrahiden kaçınmak ve taburculukta güvenli takip sağlamak.

Gözlem ve izlem

- Tanı belirsizse aktif gözlem: 6-24 saatte bir seri karın muayenesi, vital ve ağrı seyri; kötüleşmede yeniden görüntüle
- Başlangıçta USG negatif ama şüphe sürüyorsa tekrar USG / MR; erken apandisit ve invajinasyon geç görülebilir
- Enema ile redükte invajinasyonda erken nüks açısından gözlem; oral tolerans ve kliniği izle
- Postoperatif: ateş, ileus, yara-apse; komplike apandisitte antibiyotik süresi ve apse drenajı takibi
- Medikal nedende (gastroenterit, kabızlık, İYE) nedene yönelik tedavi ve hidrasyon; yanıtı değerlendir

Taburculuk ve güvenlik ağı

- Taburculuk kriteri: iyi genel durum, oral tolerans, ağrı kontrolü, güvenilir bakım verici ve erişilebilir tekrar başvuru
- Aileye yazılı uyarı: artan/lokalize ağrı, safralı-inatçı kusma, ateş, distansiyon, kanlı gaita, letarjide acil dönüş
- Belirlenmiş erken tekrar değerlendirme (genellikle 12-24 saat) planla; "tanı konmadı" ≠ "sorun yok"
- Tekrarlayan/atipik ataklarda Meckel, intermittan volvulus, İBH, üriner-jinekolojik nedenleri yeniden gözden geçir
- Multidisipliner eşik düşük tut: çocuk cerrahisi, üroloji, jinekoloji ve radyoloji ile erken iletişim

En güvenli sonuç; cerrahi karnı erken tanıyan yapılandırılmış değerlendirme, ilk basamakta USG'ye dayanan akılcı görüntüleme, zamanında konsültasyon ve belirsiz olguda seri muayene ile net güvenlik ağının birlikte uygulandığı bir planla elde edilir.

Kaynaklar

1. Reust CE, Williams A. Acute Abdominal Pain in Children. Am Fam Physician. 2016;93(10):830-836.
2. Di Saverio S, Podda M, De Simone B, et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines. World J Emerg Surg. 2020;15(1):27.
3. Expert Panel on Pediatric Imaging; Koberlein GC, Trout AT, Rigsby CK, et al. ACR Appropriateness Criteria: Suspected Appendicitis—Child. J Am Coll Radiol. 2019;16(5S):S252-S263.
4. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, et al. Functional Disorders: Children and Adolescents (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1456-1468.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulamaların yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye ve ilaç etkileşimlerine göre teyit edilmelidir.